

SPLENOMEGALIE

Dr M.S. Djebaili

Maître assistant en Médecine interne

Service de médecine interne EH DM

Laboratoire de recherche Diab-Suc

Univeristé 3, Constantine.

I- DEFINITION

- Augmentation de la taille de la rate qui devient **palpable** dans l'hypochondre gauche ou qui dépasse **14 cm** dans sa plus grande dimension à **l'échographie** ou au **scanner**



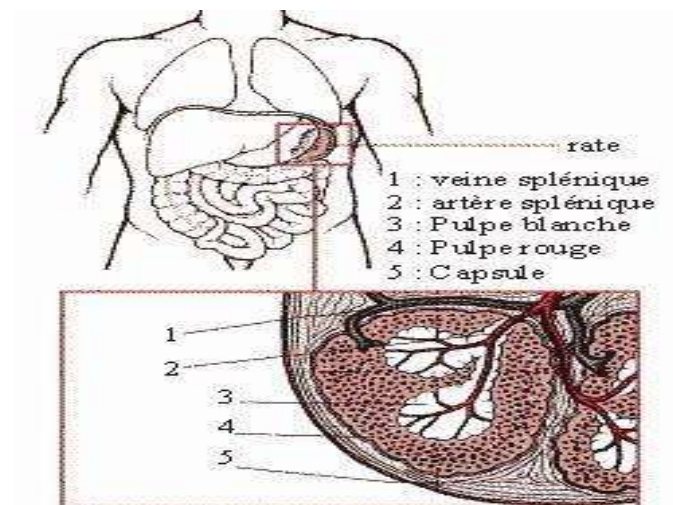
II- INTERET DE LA QUESTION

- **Fréquence** :
 - Signe d'appel dans plusieurs pathologies.
- **Dg +**: facile, clinique +++, plus rarement échographique.
- **Dg étiologique** : ++++ interrogatoire , l'ex clinique et des ex complémentaires

III - RAPPEL ANATOMO- PHYSIOLOGIQUE

- Anatomie

- Situation : HCG, au dessous du diaphragme
- Mensuration : **12-14 cm de grand axe**
4-8 cm axe transversal
6-12 cm axe antéro-post
- Couleur: **pourpre foncé**
- Poids: 150 - 200 g



III - RAPPEL ANATOMO- PHYSIOLOGIQUE

Principales fonctions de la rate

- **Organe lymphoïde** impliqué dans l'élaboration de la **réponse immune humorale** : synthèse rapide d'Ac et IgM lors de la réponse immunitaire primaire
- **Organe myéloïde** responsable de la **clairance sanguine des hématies** sénescents ou recouvertes d'Ac, et de l'élimination de débris cellulaires et microorganismes.
- **Organe très vascularisé** : Son drainage vasculaire s'effectue vers le **système porte**.
- **Rôle de stockage** des plaquettes (1/3 du pool plaquettaire), du fer, du facteur VIII.

III - RAPPEL ANATOMO- PHYSIOLOGIQUE

Le développement d'une SPMG

- Soit par **augmentation de pression dans le système porte**
- Soit par **hyperplasie ou hypertrophie du système macrophagique**
- Soit par **hyperplasie lymphoïde**
- Soit par **métaplasie myéloïde.**

IV - DIAGNOSTIC POSITIF

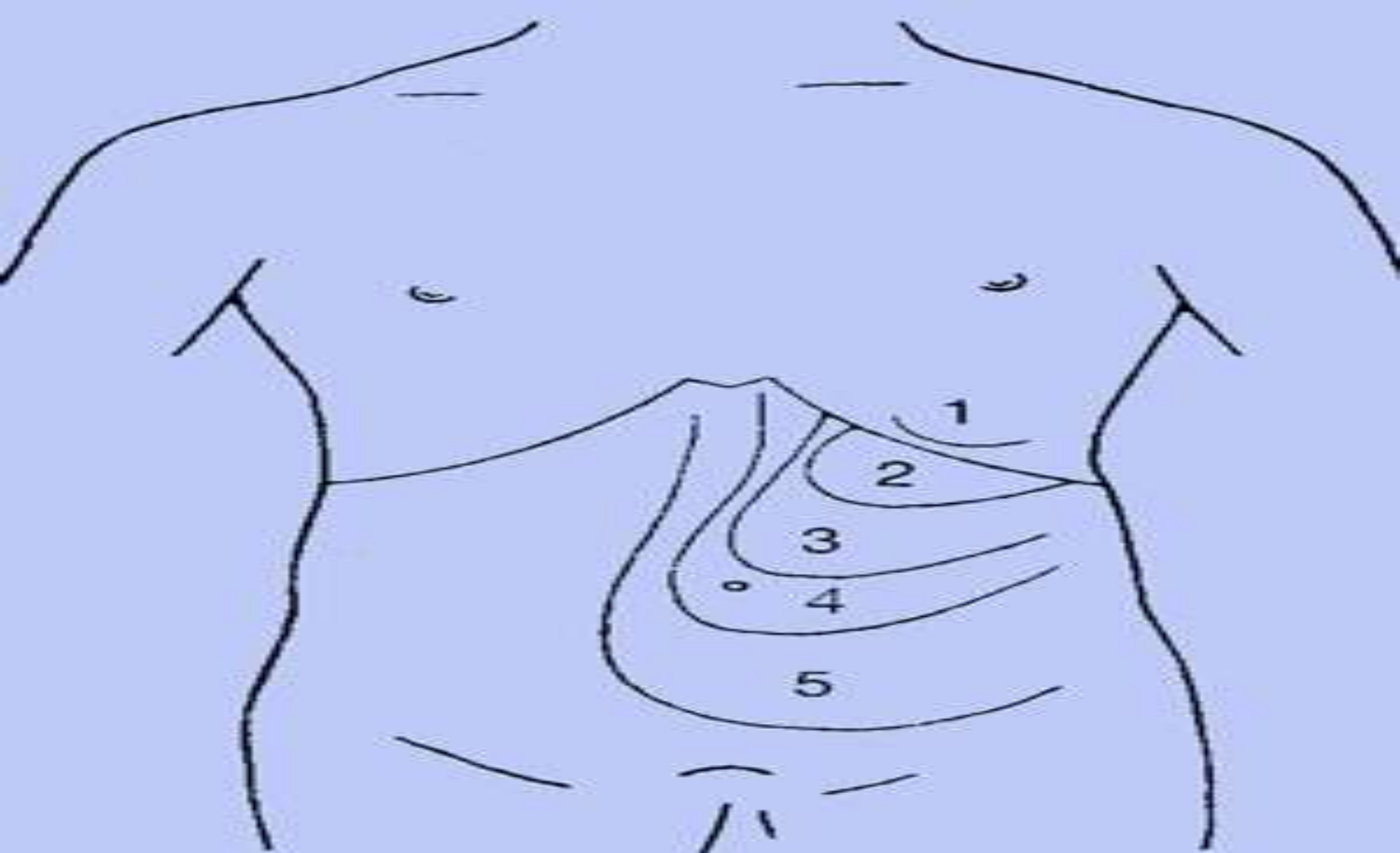
1. Circonstances de découverte

- Le plus souvent **de façon fortuite** (splénomégalie est indolore)
ou devant un signe clinique : Fièvre prolongée
Hépatomégalie
Adénopathies
Ictère
- *Troubles fonctionnels :*
 - ✓ Pesanteur de l'hypochondre gauche
 - ✓ Douleur abdominale
 - ✓ Constipation, troubles dyspeptiques
- *Complications :*
 - ✓ Infarctus splénique : douleur du flanc/basithoracique
 - ✓ Rupture de la rate : choc hémorragique +douleur
 - ✓ Hypersplénisme : pancytopénie

Toute rate palpable est pathologique
(sauf rares cas de malpositions).

- Palpation en **décubitus dorsal** ou **latéral droit**
- **Masse de l'hypochondre Gauche:**
 - ✓ Bord antérieur **crénelé**
 - ✓ Mobile avec la **respiration**
 - ✓ **Mate** à la percussion (ferme, élastique, parfois dure si SPM ancienne)
 - ✓ Surface (**régulière** le plus souvent)
 - ✓ Sensibilité (**indolore** le plus souvent)

2. DIAGNOSTIC CLINIQUE



2. DIAGNOSTIC CLINIQUE

- **Rate 0**: volume nl, non palpable même en inspiration profonde.
- **Rate 1**: palpable en inspiration profonde.
- **Rate 2**: palpable en respiration nle, ne dépasse pas l'horizontale a mi distance entre rebord costal ghe et ombilic.
- **Rate 3**: rate descend en dessous de cette ligne, ne dépasse pas l'horizontale passant par l'ombilic.
- **Rate 4**: rate descend sous l'ombilic, ne dépasse l'horizontale a mi distance entre ombilic et symphyse pubienne.
- **Rate 5**: rate descend en dessous de cette ligne, palpable FIG

3. Examens complémentaires

- Dans les cas difficiles (ascite, obésité, masse HCG d'origine indéterminée)
- Pour apprécier la taille et la structure de la rate (homogène ou non).

1) Echographie abdominale (*1ère intention*)

- **Taille** de la rate
- Anomalies associées : hépatomégalie, adénopathies,...

2) TDM : abcès ,kyste , hématome

V. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

- ***Gros rein***
- **Tumeur de l'angle colique gauche**
- **Tumeur de la queue du pancréas**
- **Tumeur du lobe hépatique gauche.**
- **Tumeur de la surrénale gauche**

Dans tous les cas, l'échographie abdominale ou le scanner permettent de lever les incertitudes

- **Interrogatoire**: âge, ATCD familiaux, origine ethnique, séjour en zone d'endémie parasitaire, ethylisme, déficit immunitaire (congénital ou acquis)
- **Contexte clinique** :
 - Fièvre
 - Signes HTP (Ascite, CVC)
 - Adénopathies périphériques
 - Ictère
 - Hépatomégalie
 - Pâleur cutanéomuqueuse
 - Signes articulaires

- **Examens complémentaires systématiques:**
 - FNS complète avec taux de réticulocytes
 - Frottis sanguin
 - Bilan d'hémolyse (BL et BG, LDH, fer sérique)
 - VS, CRP, électrophorèse des protéines, fibrinogène
 - Bilan hépatique
 - Bilan lipidique
 - Echographie abdominale

- Examens complémentaires en fonction du contexte clinique et biologique:
 - Hémocultures et séro-dg (**contexte fébrile**)
 - Echographie cardiaque (**valvulopathie/ souffle**)
 - Ex hématologiques spécialisés (**anémie, sd tm**): électrophorèse de l' Hb , myélogramme, BOM
 - Ex endoscopiques: fibroscopie OGD (**HTP**)
 - Enfin laparotomie avec splénectomie

1) Causes infectieuses

a) Bactériennes :

- Endocardite d'OSLER : cardiaque fébril valvulopathie, **hémoc** , écho-C (**ETO**: végétations)
- S à pyogènes : tableau septique, hyperleucocytose à PNN, **hémoc**.
- Fièvre typhoïde: fièvre plateau, pouls dissocié, SPM, tufos marqué, angine de Duguet, leucopénie), **seroDg Widal et Felix**.
- Brucellose: consommation de lait cru, triade sudoro-algique, leucopénie, **sero dg de Wright** et **hémoc**.
- TBC hématopoïétique : sd infectieux ,AAA, SPM/HPM, pancytopénie, IDRT voir Biopsie.

b) Virales :

- Contexte infectieux
- ✓ **NFS**: sd mononucléosique
- **MNI** : F° 39-40 $^{\circ}$, angine , ADP cervicales, asthénie ,SPM
Ex 1 $^{\circ}$: MNI test si - : sérol EBV
sérol **VIH**
sérol **VHB, VHC, VHA,CMV**

VI. DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

B. ETIOLOGIES

c) Parasitaires :

- **Paludisme**: zone d'endémie, caractère de la fièvre , SPM modérée lors des 1ers accès palustre
Dg : **Etude du frottis , goutte épaisse**, IF
- **Leishmaniose** : zone d'endémie, fièvre anarchique avec **énorme SPM**, ADP/HPMG
Dg : pancytopénie, hyperglobulinémie monoclonale , **frottis médullaire ou ggaire, PCR**
- **Bilharziose**: notion de bains infectants, HPM/SPM, fièvre, éosinophilie sanguine.
Dg : MEV des œufs par **biopsie hépatique ou rectale**
- **Hydatidose splénique**: contage hydatique, zone d'endémie, hypereosinophilie
Dg : **Echo + sérologie**
- **Rarement**: Toxoplasmose

2) Maladies de systèmes

a) Lupus érythémateux disséminé :

- Femme jeune, signes cutanés , signes articulaires...
- La SPM peut être précoce si anémie hémolytique auto-immune
- *Dg* : ***Ac antiDNA natif***

b) Maladie périodique (fièvre méditerranéenne familiale) :

- Origine ethnique (arabe - juifs du Maghreb)
- Accès fébriles avec DI articulaires et/ ou abdominales
- SPM inconstante

c) Maladie de Still de l'adulte

d) Sarcoïdose (rarement)

3) Hypertension portale

clinique: ascite, SPM, CVC.

Ex: FOGD (VO), FNS (anémie)

a) Obstacles sur les veines sus hépatiques:

- Sd de BUDD CHIARI: HPM, signes HTP , echo (obstacle)
- Maladie veino-occlusive

b) Obstacle intra hépatique :

- sarcoïdose
- **cirrhose** alcoolique.....).

c) Obstacle pré hépatique

VI. DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

B. ETIOLOGIES

4) Maladies hématologiques

a) **Hémolyse** : « Splénomégalias de séquestration »

- **Constitutionnelle**

- Thalassémies / Drépanocytose
- Maladie de Minkowski chauffard
- Déficit enzymatique (déficit en G6PD, pyruvate kinase)

- **Acquises**

- Immunologiques
- Non immunologiques

b) **Hémopathies** :

1. Leucémies

2. Lymphomes

VI. DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

B. ETIOLOGIES

5) Maladies de surcharges

- Amylose
- Maladies métaboliques congénitales
- Maladie de Gaucher

6) SPM tumorales

- **Tm bénignes**: rare, découverte opératoire
- **Tm malignes**:
 - ✓ Primitives : angiosarcome, fibrosarcome (Echo + TDM)
 - ✓ Secondaires : métastases d'origine digestive++
- **kystes**:
 - ✓ Vrais kystes : hémangiome, lymphangiome, K hydatique
 - ✓ Faux kystes : hémorragiques, séreux, inflammatoire

Conclusion:

- La présence d'une SPM est toujours pathologique.
- La recherche de son étiologie est obligatoire.

